

MediScribe 临床接诊智能助手 · 医生使用指南

版本: v2026.9.1 (2026-05-03 编制, 2026-09-10 修订: 平板窄屏折叠布局、病程时间轴切换文书、部分文书类型质控评分"仅供参考"披露、AI 余额不足时的降级行为) | 适用场景: 中医门诊 / 急诊 / 住院 / 影像阅片 | 服务地址: <https://mediscribe.cn>

本指南按医生**实际工作场景**组织。每个按钮、每个字段都对应系统中真实的功能, 不存在"理论上能做"但实际未实现的描述。

一、系统概述

1.1 它能帮你做什么

痛点	系统提供
写病历占用诊疗时间	AI 一键生成 : 根据问诊信息自动生成结构化病历草稿
病历文字不规范	AI 润色 : 把口语化表述改写为标准医学书面语
漏写关键字段被扣分	AI 质控 : 依据浙江省 2021 版评分标准实时检测 + 一键补全
重复录入既往史/过敏史	患者纵向档案 : 7 项稳定字段跟随患者, 下次复诊自动带入
问诊耗时长	语音录入 : 实时识别医患对话 → AI 整理为结构化字段
复诊忘了上次说啥	历史病历参考卡 : 复诊时自动展示上次病历全文
影像阅片繁琐	影像 AI 分析 : CT/MR/X 光多帧批量分析 → 结构化报告

1.2 系统不会替你做什么 (重要)

- 不会替你诊断**: 所有 AI 输出都是"草稿", 必须由医生审核后才能签发
- 不会自动开处方**: 处理意见、用药方案需要你自己写或确认
- 不会替你担责**: 签发的病历署名是你, AI 是辅助工具不是责任主体

二、登录与角色

2.1 登录入口

浏览器访问 <https://mediscribe.cn> → 输入用户名 + 密码 → 进入对应工作台。

推荐浏览器: Edge / Chrome 最新版（语音实时转写依赖现代 Web Audio API）。浏览器版本低于 Chrome 80 会打不开，页面会直接提示。**如果用的是 360 / 2345 浏览器，点地址栏旁边的内核图标切到「极速模式」即可，不必换浏览器。**

登录后可以连续用 30 天，中途不会反复要你重新登录；换一台电脑登录不影响另一台。

2.2 第一次登录必须改密码

全院统一发的是同一个初始密码，所以**第一次登录会弹出改密码窗口，不改就用不了系统**——这个窗口关不掉，也跳不过。

- 新密码至少 6 位，**不要用工号或生日**（工号在院内是公开的，用它当密码等于没设密码）
- 改完会提示「密码已修改，可以开始使用了」，然后正常进入工作台
- 改密码之后，你之前在别的电脑上登录的会话会失效，需要用新密码重新登录

管理员帮你重置密码后，下次登录同样会再要求你改一次。

2.3 角色与权限

角色	默认进入	可用功能
临床医生 (doctor)	门诊工作台 /workbench	门诊 / 急诊 / 住院 接诊；患者影像分析（单张快速分析）
影像科医生 (radiologist)	PACS 工作台 /pacs	批量 DICOM 上传、AI 分析、报告签发
质控员 (qc_officer)	质控复核台 /qc	只读复核已签发病历、退回整改、看质控看板； 不进管理后台、不能写病历、不能用 AI
护士 (nurse)	—	当前版本无工作面（不能写病历、不能用 AI 功能）
科室管理员 (dept_admin)	管理后台 /admin	本科室用户管理、患者管理； 只能在本科室建号，不能填 HIS 工号、不能建质控员/影像医师、不能用批量开户
医院管理员 (hospital_admin)	管理后台 /admin	全院用户管理（含批量开户与工号绑定）、患者管理、配置维护
超级管理员	管理后台	全部 + 查看质控评分标准、操作日志、Token 用量

如忘记密码或账号异常，请联系系统管理员（不要自己反复尝试登录，会被风控临时锁定）。

三、门诊工作台核心流程

3.1 界面结构（三栏）

[顶部工具条] 患者徽章 · 初诊 / 复诊 · 历史病历 · 影像分析 · 切换至急诊

[左：问诊录入]

[中：病历编辑]

[右：AI 辅助建议]

- 患者档案

- 一键生成 / 润色

- 追问建议

- 语音录入

- AI 质控

- 检查建议

- 主诉/现病史

- 出具最终病历

- 质控提示

- 体格检查

- 导出 Word

- 诊断/治疗

平板/窄屏（2026-09 新增）：屏幕宽度不够三栏并排时（如平板竖屏），左右两栏会自动收成侧边把手，点「展开问诊录入」「展开AI 建议」即可展开使用；转回横屏或宽屏后自动恢复三栏，不影响任何数据。

3.2 完整接诊流程（初诊场景）

步骤 1：新建接诊

顶部「+ 初诊」按钮 → 弹窗输入患者基本信息（姓名 / 性别 / 年龄 / 联系方式）→ 创建成功后患者徽章变绿色显示。

如果是老患者复诊，点「复诊」→ 输入患者姓名搜索 → 选中后自动恢复上次接诊的工作台快照。

步骤 2：填写问诊信息（左栏）

患者档案卡片（顶部黄色边框）

7 个字段跟随患者纵向档案：**既往史 / 过敏史 / 个人史 / 家族史 / 长期用药 / 婚育史 / 宗教信仰**（月经史属每次接诊重填，见下方问诊字段）。

- 复诊时：默认折叠，已有内容显示"X 天前由某医生确认"的时间戳
- 字段超过 180 天未更新变橙色提醒、超过 540 天颜色加深（长期用药 30 天即提醒），可以点字段右侧「✓ 仍准确」一键刷新时间戳（不改内容只确认）
- 修改后保存按钮会显示「保存档案+问诊」（合并保存）
- 字段下方的小标签（如「标准否认句」「否认外伤手术史」）点一下即插入整句标准句式，插入后自行核对

主诉（必填）：症状 + 持续时间。如「发热伴咳嗽 3 天」。口语速记（如「左边胸口肋骨痛10来天」）生成时会自动规范为医学用语，症状/部位/时间不会被改动。

现病史（必填）：起病经过、症状演变、诊治经过、一般情况（饮食/精神/睡眠/二便）。

现病史下方有常用句标签（「否认发热接触」「一般情况可」，复诊另有「病史同前」「较前好转」等），点一下插入。

月经史（女性患者显示）：初潮/周期/经量/末次月经；绝经写「XX岁绝经」。质控要求育龄期女性必填。

复诊场景特别提醒：现病史**必须**写明"上次治疗后症状变化"（好转 / 无变化 / 加重），否则质控不通过。系统会有黄色警告条提示。

复诊自动带入：复诊开始时系统自动带入上次的病发时间/诊断/治则治法/月经史（只补空白项，可修改）；舌脉和体检需本次重新录入。要整份带入上次内容，点表单右上「同步上次病历」。

体格检查：- 生命体征（体温/脉搏/呼吸/血压/身高/体重）：门诊普通展示，**急诊红色标记为必填** - 录入的数值会做生理极限校验（体温 25-45℃、脉搏 0-300、SpO₂ 0-100 等），**超出会拒绝保存并提示怎么改**；收缩压填得比舒张压低也会被拦（两框填反的典型情况）- 一般体检 + 中医四诊（望/闻/问/切）+ 辅助检查

辅助检查：已有检查结果原样填入；无检查写「暂无」（不要留空，会扣分）。

诊断与治疗意见（可折叠）：- 中医疾病诊断 / 中医证候诊断 / 西医诊断 - 治则治法 / 处理意见 / 复诊建议（必填） / 注意事项

诊断选码（病案首页质控要求，2026-08 新增）：- 三个诊断框都支持**边输边选**官方编码字典（国标 ICD-10 医保 2.0 版 + 中医病证国标），选中后诊断名右侧出现绿色「√码」，表示已带标准编码 - 三种输入方式都能搜到：**中文名**（输"高血压"）、**拼音首字母**（输 yfxgxy 出"原发性高血压"；带数字的病名数字照打，如 2xtnb 出"2型糖尿病"）、**编码**（点号可省略，输 i10x09 与 I10.x09 等价）- 手动输入完整诊断名不选码也行：与字典**同名唯一**时系统保存时自动补码；同名多码或字典没有时不补（宁缺勿错），回写 HIS 时该条只带名称 - **西医诊断是多条目列表**：可加多条，单选按钮标记**主诊断**（第一条默认）；删除主诊断后自动顺位；住院端每条还要选**入院病情**（有 / 临床未确定 / 情况不明 / 无）

填完点底部「保存问诊信息」。

步骤 3：AI 生成病历草稿（中栏）

中栏顶部按钮（按使用顺序）：

「 一键生成」

依据左栏问诊信息生成完整病历草稿。约 5-15 秒，**逐字"打字机"显示**——出字过程不要打断。

生成的病历包含完整章节（按浙江省法定评分标准 + 医院模板）：- 【主诉】【现病史】【既往史】【过敏史】【个人史】【月经史】（女性）【家族史】- 【体格检查】（含生命体征、中医四诊、其余阳性体征）- 【辨证分析】（依据本次录入的症状与舌脉自动生成）- 【辅助检查】- 【诊断】（中医诊断 X — 证候 Y / 西医诊断）- 【治疗意见及措施】（治则治法 / 处理意见 / 复诊建议 / 注意事项）

⚠️ AI 不会编造未提及的信息——左栏没填的字段，病历对应位置会写「[未填写，需补充]」占位符。

「🖌️ 润色」

把生成的病历或你手写的内容做语言改写：口语 → 书面医学语言；去除重复；段落规范化。**不会增删医学事实。**

「🔵 AI 质控」

依据浙江省法定评分标准检测病历质量，几秒内完成。结果显示在右栏「质控提示」Tab。

评分等级（满分 100，与省标准一致）：- 门急诊病历：≥90 **合格** ✓ / <90 **不合格** ✗ - 住院病历：≥90 **甲级** ✓ / 80-89 **乙级** ⚠️ / <80 **丙级** ✗

「日常病程」「上级查房」的评分说明（2026-09-16 更新）：这两类文书的客观评分规则已上线——会检查记录内容是否过于简单（一句“今日无特殊”会被扣分）和病程记录间隔是否超过 3 天（病情稳定也至少每 3 天记 1 次，省标准要求）。诊疗合理性、抗菌药物使用等主观条款仍需科室人工检查，机器不越权评判。

注意：**能否出具最终病历看的是“是否达到合格线（≥90 分）”**——达线即可签发。达线但仍有规则扣分项时，面板会显示「规则扣分项（可出具；修复后重新质控可提分）」；未达线时显示「必须修复」，修完重新质控过线才能签。

问题分类：- **🔴 必须修复 / 规则扣分项**（结构性问题）：缺少必填章节、字段缺失等法定扣分值。**分数未达 90 时无法出具**；已达线时显示为可选修复（提分用）。- **🟠 质量建议**（橙色标签）：高/中/低风险的改进建议，扣分较少。

「📄 补全缺失项」

仅在质控检出“必须修复”问题时显示。点击后 AI 自动补充**法定扣分项**的缺失字段（基于问诊已有信息；纯建议类提示不会被自动改写）。**补全后建议重新质控确认。**

AI 写入内容必须医生过目（黄色 chip 确认机制）：- 补全/逐条修复写入的每个字段，编辑区顶部会出现淡黄色提示条，列出字段名 chip，正文对应行同步黄色高亮 - **点击 chip 跳转到该行查看，看完该 chip 自动消除**；直接编辑该行也会消除 - 如果签发时还有未确认的 chip，会弹窗列出**每处字段名和写入的内容摘要**，医生核对无误点「一并接受并签发」才能继续

「✓ 出具最终病历」

最后一步，把病历**正式签发**。签发后： - 病历变只读，**不能再编辑** - 历史病历列表里出现这条记录 - 患者档案的字段时间戳被刷新

⚠️ 如果质控未通过（有“必须修复”项），点这个按钮会弹窗拒绝。先去右栏修复，或点「补全缺失项」。

签发前两道提醒（2026-08 新增）： - 病历里还有「[未填写，需补充]」等占位符时，最终病历弹窗顶部会出**黄色警告**列出条数——占位符签出去必被质控扣分，建议先补全 - 还有未确认的 AI 补全 chip 时会先弹确认框（见上文 chip 确认机制）

签发后的质控复核与退回整改（2026-08 新增）： - 签发的文书会进入**质控员复核队列**（三级质控的科室审核环节），质控员可能给出「退回整改」结论 - 被退回时，你的工作台**顶部会出现橙色横幅**「有 N 份病历被质控退回」，点开能看每份的复核人和整改意见 - 整改方式：**住院文书**修改后重新签发即可，横幅自动消失并重新进入复核；**门急诊病历**签发后不可直接改，请联系管理员走病历修订通道

「📄 导出 Word」

下载病历为 .docx 文件。任何时候都可点（草稿或已签发都行）。

步骤 4：右栏 AI 建议（贯穿整个接诊）

右栏有三个 Tab。追问建议与检查建议**填好主诉后点按钮触发**（不是自动跑），几秒返回。

「💡 追问建议」

点「生成追问建议」后给出“还应该追问什么”——尤其是鉴别诊断方向。每条建议下方有**选项按钮**，点选即把患者回答记进问诊；右下角 👍 / 👎 用来反馈建议质量。**未读建议数量在 Tab 上显示红点**。

「🔍 检查建议」

点「生成检查建议」后给出推荐检查及理由。每条右侧「写入」按钮把该检查写进病历（写入后变「已写入」，再点即撤销）。

「⚠️ 质控提示」

只在你点过「AI 质控」后才有内容。逐条列出病历问题，每条支持： - **逐条修复**：调用 LLM 生成针对该字段的修复建议文本 - **写入病历**：把修复文本写到病历对应章节 - **撤销**：放回写入前状态

四、HIS 叫号与病历回写

本章只在医院 HIS 已对接的情况下有效。没对接时工作台不会出现叫号入口，按第三章手动建接诊即可，其余流程完全一样。

4.1 患者是怎么进来的

对接 HIS 之后，你**不需要手动建接诊**：

1. 你在 HIS 里接诊一位病人
2. HIS 把这次就诊推给 MediScribe，系统自动建好患者档案、按你的**工号**派给你
3. 你的工作台右下角出现叫号角标，同时响一声提示音、右上角弹出横幅

一位医生可能有多个工号（本人门诊号、住院号、助理号）。不管 HIS 用哪个号推过来，都会派到你本人账号下，**病历署名永远是你本人**，不会出现助理的名字。

4.2 叫号队列怎么用

点右下角角标打开「今日接诊队列」：

- 列出今天 HIS 推过来的所有患者，带姓名、性别、出生日期、科室
- 状态分「待接诊」和「已签发」
- 点某一条即可直接进入该患者的工作台开始写病历
- 顶部显示连接状态：「实时连接」正常；「连接中断（自动重连中）」时会自己恢复，恢复后队列会自动补齐这期间的患者，不用刷新页面
- 没有推送时显示「今日暂无 HIS 推送的接诊」

你正在写病历时来了新患者，系统只提示不中断——不会把你切走。写完当前这份再点新的即可。

4.3 病历怎么回到 HIS

点「出具最终病历」签发之后，系统**自动**把病历写回 HIS，你不需要做任何额外操作。回写结果显示在叫号队列里：

标签	含义	你要做什么
已回写 HIS	病历已送到 HIS	去 HIS 里核对后保存即可
未回写	HIS 连接不在线	等连接恢复系统会自动补送；急用可点「重试」
回写失败	送过去但 HIS 没收下	点「重试」；反复失败请联系信息科

签发时若 HIS 恰好不在线，会提示「病历已签发，但 HIS 连接不在线，未能回写」——**病历不会丢**，系统在后台会持续重投，恢复后自动送达。

回写过去的病历在 HIS 里是**草稿/待确认**状态，需要你在 HIS 界面核对后确认保存，才成为正式病历。这是有意设计的：AI 写的东西必须经你过目才算数。

4.4 患者档案出现黄色提示条

复诊时如果 HIS 推来的过敏史、既往史与我方档案里存的不一致，档案卡上会出现黄色提示条，给你两个按钮：

- **采纳 HIS**：用 HIS 的值覆盖我方记录
- **保留本地**：保留你之前确认过的内容

系统**不会自己替你选**——两个值都可能是对的，只有你能判断。在你选之前，原有的值不变，也不会丢掉 HIS 推来的新值。

五、语音录入完整流程

语音卡片在左栏问诊面板里，无论门诊/住院/急诊都通用。

5.1 录音

点「🎤 **开始录音**」→ 浏览器请求麦克风权限（首次需允许）→ 录音中实时把识别文字显示在转写区。

实时转写工作时：医生说话同时屏幕逐字出文字（阿里云 paraformer-realtime-v2）。**实时转写不可用时**：会出现「实时转写未启用，录音继续，停止后自动云端转写」黄色提示——继续录音即可，停止后会用 qwen-audio 整段转写。

录音时长建议：- 普通门诊单段对话：1-5 分钟 - 复杂病例 / 详细问诊：5-15 分钟 - 单次最长建议 30 分钟以内（更长会让 AI 整理质量下降）

⚠ 兜底转写（实时不可用时）建议**单段不超过 3 分钟**，超过会有质量下降风险。

5.2 续录

录完一段后，可以点「🎤 **继续录音**」补充内容。新内容自动追加在原转写后面，中间用 --- 续录 --- 分隔。

适用场景：- 患者去做检查，回来后补录检查结果 - 中间被打断接电话，回来继续 - 想到漏问的内容补一句

5.3 AI 整理

录音停止后，点「🤖 **AI 分析并整理**」——10-30 秒，AI 会做几件事：

- 1. **本段对话摘要**：1-2 句话概括对话内容
- 2. **角色分析**：识别每句话是医生说的还是患者说的（不确定的标"待确认"）
- 3. **结构化预览**：把对话内容拆成问诊字段（主诉 / 现病史 / 既往史 / 体格检查...）

预览卡片会展示拆出的内容，确认无误后点「📄 插入病历」（病历已生成时）或「插入问诊」（病历未生成时）。

5.4 续录场景的智能合并（核心特性）

如果你已经生成了病历，再做续录 + 重新分析时，AI 会做**增量分析**：

- **叙述类字段**（现病史、既往史、个人史等）：仅输出**新增内容**，前端追加到原章节末尾，**保留你之前的手改**
- **原子字段**（主诉、诊断、生命体征评分等）：基线已有的不重复输出；对话明确修正时输出新值

举例：- 原现病史：「3 小时前突发头痛伴左侧肢体无力」- 续录："还发烧 39 度" - AI 输出：现病史只补一句"伴发热，体温 39℃" - 插入病历：原内容 + 换行 + 新内容（**不会冲掉你手改的措辞**）

5.5 录音清空与重录

「🗑️ 清空重录」会**删除当前录音 + 转写内容**，谨慎使用——删除后无法恢复。

通常用在：录音质量太差全部重来，或者录错了别的患者的对话。

六、住院工作台

6.1 进入路径

- 顶部「切换至住院」按钮
- 或新建接诊时选择"住院"
- 急诊接诊"患者去向 = 收入住院"时，急诊页面下方红色栏「**一键转入住院接诊** →」按钮

6.2 界面布局（四栏）

[病区视图]	[入院问诊]	[病历编辑区]	[右侧 4 Tab]
患者列表	同门诊+	入院记录	AI 建议
床位搜索	专项评估	/ 病程记录	病程时间轴
	月经史(女)		问题列表
			体征

6.3 病区视图（最左）

列出本科室在院患者，按床位排序。点击患者名 → 加载该患者的住院工作台快照。

「+ 新建住院接诊」按钮：弹窗输入患者信息开住院记录。

6.4 入院问诊面板（与门诊区别）

保留：患者档案卡片、语音录入、主诉、现病史、体格检查、辅助检查。

新增「专项评估」区（住院特有，缺一项扣分）：

1. **病史陈述者**（必填）：患者本人 / 配偶 / 子女 / 父母 / 陪护人员 / 急救人员
2. **康复需求评估**：无 / 需肢体 / 需语言吞咽 / 需心肺 / 需综合康复
3. **疼痛评分**（NRS 0-10 滑块）
4. **VTE 风险**：低危 / 中危 / 高危 / 极高危
5. **营养评估**：营养良好 / 存在风险 / 营养不良
6. **心理评估**：良好 / 轻度焦虑 / 明显焦虑需会诊
7. **月经史**（女性必填）：末次月经日期、本次特点

新增「入院诊断」区（2026-08 结构化）：中医疾病/证候诊断 + 西医诊断多条目列表。选码方式与门诊一致（中文名 / 拼音首字母 / 编码三种输入，见 3.2 步骤 2）；西医每条需单选**主诊断**并选择**入院病情**（有 / 临床未确定 / 情况不明 / 无）——这两项直接进病案首页，缺了会被质控扣分。

移除：治疗意见区块（住院端通过病程记录处理）。

6.5 住院病历分两类

A. 入院记录（首份病历）

中栏点「**一键生成**」生成"入院记录"格式（区别于门诊病历模板，篇幅更详细）。流程跟门诊一致：润色 → 质控 → 出具最终病历。

B. 病程记录（贯穿整个住院期）

通过右栏「**病程记录**」Tab 时间轴管理：- 入院记录（已签发显示在最上）- 首次病程记录（入院 8 小时内）- 日常病程记录（按需添加）- 上级查房记录 - 出院记录（出院前）

点击时间轴某条（或点「+ **首次病程 / 日常病程 / 上级查房 / 出院记录**」新建）→ 中栏编辑器**自动切换到该份文书**——与中栏顶部的文书类型下拉是同一回事，切换时各文书的草稿互不串扰：- 草稿（`status='draft'`）：可继续编辑，自动保存 - 已签发（`status='submitted'`）：打开为只读

小技巧：切文书前不用手动保存，正在写的内容会按原文书类型自动暂存，切回来还在。

6.6 顶部「办理出院」

二次确认后患者从病区列表移除，已签发的病历仍可在"历史病历"查阅。

6.7 时效合规提醒

入院记录、首次病程、出院记录都有时效要求（如入院 24 小时内须签发入院记录）。系统顶部有红色倒计时栏，**超期变红预警**。

七、急诊工作台

7.1 进入路径

门诊顶部「切换至急诊」按钮，或直接访问 /emergency 。

7.2 与门诊的区别

维度	门诊	急诊
配色	蓝色	红色（视觉警示）
生命体征	普通展示	红色高亮，必填
额外字段	无	患者去向（收入住院 / 留院观察 / 其他）
流转操作	无	底部 Disposition 栏

7.3 患者去向 + 流转栏

填完治疗意见后，最后一项是**患者去向**。选完后底部出现彩色栏：

- 「收入住院」（红栏）→ 「一键转入住院接诊 →」按钮：自动创建住院 encounter + 跳转到住院工作台
- 「留院观察」（黄栏）→ 「+ 追记留观记录」按钮：追加留观期间观察记录
- 「其他」：不显示流转栏

7.4 急诊场景常用流程

患者来 → 快速录入主诉 / 生命体征（必填） / 辅助检查 → 生成病历 → 选择去向： - 重症 → 收入住院（一键转） - 需观察 → 留院观察（每隔几小时追记） - 普通 → 离院（出具最终病历，告知复诊）

八、影像分析

系统提供两种影像分析路径，依据用户角色不同：

8.1 临床医生 — 单张快速分析（接诊内嵌）

入口：门诊 / 住院 / 急诊工作台顶部「 影像分析」按钮。

支持格式：JPG / PNG / WebP / DCM (DICOM 单文件)

操作流程：1. 弹窗内点上传按钮选影像文件 2. 选择影像类型（胸部 X 光 / 头颅 CT / 腹部超声 等） 3. 「分析」按钮 → 10-20 秒后显示 AI 分析结果 4. 「插入病历」→ 分析结果直接写入【辅助检查】章节

适用场景：患者拿着片子来，快速 AI 解读辅助你判断；不需要正式签发。

8.2 影像科医生 — PACS 工作台批量分析

入口：影像科医生登录后默认进入 `/pacs`。

支持格式：ZIP / RAR / 7Z / TAR / TAR.GZ 等压缩包（含多个 .dcm 文件），支持 ISO 镜像。

完整流程（4 步）：

步骤 1：上传影像

「+ 新建检查」按钮 → 选择患者（已存在或新建）→ 拖拽压缩包 → 上传后系统自动：- 解压 → 标准 STOW-RS 协议存到 Orthanc DICOM 服务器 - 多线程渲染所有切片缩略图（256px）+ 高清预览（1024px）- 缓存到 Redis，秒级加载

幂等校验：同一影像重复上传不会创建新检查（按 StudyInstanceUID 识别）。**跨患者保护：**同一影像绑定到不同患者会被拒绝（防止误关联）。

步骤 2：选择关键帧

进入检查 → 左侧网格显示所有切片缩略图 → 点击预览。

操作：- 「自动抽帧」：智能采样 18 帧（CT/MR：头部 3 + 中部 12 + 尾部 3，病变常在中段）- 「全选」/「清空」- 单击切片缩略图 → 右侧大图预览 - 大图支持窗位窗宽实时调节（拖动鼠标）+ 平移 / 缩放

单次分析最多帧数（按模态自适应）：CT/MR 18 帧、X 光 4 帧、超声 6 帧。

步骤 3：AI 分析

「 发送分析」按钮 → 选中的帧 → 阿里云通义千问 VL 模型 → 30 秒-2 分钟。

返回结构化报告（按【影像类型】【影像所见】【印象】【建议】四段式）。

步骤 4：审核与签发

- 左侧只读显示 AI 原文
- 右侧 TextArea 可编辑最终报告
- 「重新选帧」回退；「确认发布」签发为正式报告

签发后： - 报告对该患者的临床医生可见（在接诊工作台「既往影像报告」卡片自动显示） - 影像变为只读，不能删除（医疗审计合规）

8.3 删除规则

- 未发布的检查（pending / analyzing / analyzed 状态）：可删除（连带 Orthanc study + 缓存全清）
- 已发布的报告：不能删除（保留追溯链）

九、患者纵向档案与历史病历

9.1 患者纵向档案 (PatientProfileCard)

7 项稳定字段跟随患者：既往史 / 过敏史 / 个人史 / 家族史 / 长期用药 / 婚育史 / 宗教信仰。（月经史属每次接诊重填，不进纵向档案）

特性： - 修改后保存到患者档案表（不属于本次接诊） - 复诊时自动带入，无需重填 - 每个字段记录"上次确认时间 + 确认医生" - 超 180 天未确认橙色提醒、超 540 天颜色加深（长期用药 30 天即提醒），可点「√ 仍准确」一键刷新时间戳不改内容

9.2 历史病历查阅

顶部「📄 历史病历」按钮 → 抽屉展开所有已签发病历列表。

支持： - 按患者搜索 - 按时间范围筛选 - 点击查看完整病历内容（只读） - 复诊时系统会自动在中栏顶部展示上次病历参考卡片

十、按钮速查表

10.1 顶部工具条

按钮	作用	备注
+ 初诊	新建患者接诊	弹窗输入基本信息
复诊	找老患者继续接诊	搜索患者名
历史病历	查阅已签发病历	抽屉式列表
影像分析	单张影像 AI 分析	临床医生用
切换至急诊/门诊	工作台切换	保留接诊号
切换至住院	进住院工作台	同上

10.2 病历编辑区

按钮	作用	何时点
 一键生成	AI 生成病历草稿	问诊填好后
 润色	优化文字表达	病历有内容后
 AI 质控	检查病历质量	病历快签发前
 补全缺失项	自动补失分项	质控失败时显示
✓ 出具最终病历	签发病历	质控通过后
 导出 Word	下载 .docx	任何时候

10.3 语音录入

按钮	作用
 开始录音	开始录音并实时转写
 继续录音	续录补充内容
 停止录音	停止后保存音频 + 转写文本
 AI 分析并整理	把对话拆成结构化字段
 插入病历	把整理结果写入病历
 清空重录	删除当前录音重来

10.4 AI 建议（右栏）

Tab	作用
 追问建议	AI 实时建议你还要追问什么
 检查建议	AI 建议开哪些辅助检查
 质控提示	病历缺陷列表（点 AI 质控后显示）

十一、常见问题 FAQ

Q1：登录进去白屏 / 一直转圈

→ 完全关闭浏览器重新打开（不是只关 tab，整个 Edge / Chrome 进程退出）。→ 仍然不行：地址栏访问 `edge://net-internals/#sockets` 点 Flush socket pools，再访问。

Q2：AI 一键生成几秒后没反应

→ 检查左栏问诊是否已**保存**（点过保存按钮）。仅在 store 里没保存的内容 AI 看不到。→ 仍然不行：F12 看 Network 是否有 `quick-generate` 请求；告诉技术支持。

Q3：录音一直显示「实时转写未启用」

→ 网络环境问题，前端会自动 fallback 到云端整段转写。**录音照常进行，停止后会自动转写。**→ 单段建议不超过 3 分钟（云端兜底转写质量随时长下降）。

Q4：质控显示甲级病历但又说"必须修复"

→ 这是**矛盾状态**——分数高（90+）但有"结构性问题"。→ 处理：先修复"必须修复"的项（点逐条修复或一键补全），再重新质控。修复后等级会重新评。

Q5：AI 整理把我手改的内容覆盖了

→ 旧版本确实有问题，现已改为**增量分析**——叙述类字段只追加新增内容，不覆盖你的手改。→ 如果还有覆盖现象，请截图反馈。

Q5.1：AI 提示「余额不足，请联系管理员充值」

→ AI 供应商账户余额耗尽。此时：**AI 生成/润色/整理暂时不可用，但质控的规则评分照常出**（依据省标准的结构检查不依赖 AI），病历**手写、保存、签发、回写 HIS 全部不受影响**。→ 处理：联系管理员充值，充值后立即恢复，无需重启或重新登录。

Q6: 插入病历后内容跑到错误的章节

→ 字段映射有 bug，记下当时的转写内容 + 错误位置 + 正确应该在哪个章节，反馈给技术支持。

Q7: 影像分析报错 / 转圈不出结果

→ 单图分析超时通常是阿里云模型暂时性问题，等几分钟重试。→ DICOM 上传失败检查文件是否完整压缩包。

Q8: 刷新页面后数据丢了

→ 已签发病历不会丢（在历史病历里）。→ 草稿状态：问诊信息每次保存才入库；病历内容每 5 秒自动保存草稿。→ 语音转写：跨刷新自动恢复（按接诊隔离）。

Q8-1: 断网时写的病历会不会丢

→ 不会。断网时底部状态条会变成「网络已断开，内容暂存本机，恢复后自动补传」，保存失败也会提示「已暂存本机稍后补传」——内容存在本机浏览器里，联网后自动补发。→ **此时不要清浏览器数据、不要换浏览器**，否则暂存的内容会一起被清掉。→ 状态条恢复成「病历 X 分钟前保存」就说明已经传上去了。

Q9: 网络抖动 / ERR_CONNECTION_CLOSED

→ 网络层间歇问题，**刷新一次通常能恢复**。→ 系统更新（部署）时会有几十秒的接口中断，属正常现象，稍等即恢复。→ 反复出现请告知技术支持。

Q10: 误签发了病历怎么办

→ **签发后无法直接撤销**（医疗审计合规）。需要联系系统管理员后台处理。→ 签发前一定要确认内容无误。

Q11: HIS 里接诊了，工作台没看到这个病人

先看叫号队列顶部是不是「连接中断」——是的话等它自动重连，恢复后会自动补上。若显示「实时连接」但仍没有，多半是这个**工号还没在系统里开户**，或 HIS 推的是你的另一个工号而那个号没登记，请联系信息科补登记后让 HIS 重推一次。

Q12: 病历签发了，HIS 里看不到

打开叫号队列看这条的标签： - 「未回写」= HIS 连接不在线，系统会自动补送，也可以点「重试」 - 「回写失败」= 送过去但 HIS 没收下，点「重试」；反复失败联系信息科 - 「已回写 HIS」= 已经送到了，去 HIS 里找**草稿/待确认**状态的病历，确认保存即可

三种情况**病历都不会丢**，我方库里始终有一份完整的。

Q13: AI 生成时提示"您有一个 AI 生成任务正在进行中"

同一个账号同时只能跑一个 AI 生成任务。等上一个跑完（或刷新页面）再点即可。若你确实没在跑，可能是上次生成中途关了页面，等约 2 分钟自动释放。

十二、医生使用建议（最佳实践）

12.1 推荐工作流

新建接诊 → 患者档案确认（复诊一秒，初诊详细问） →
语音录音/打字录入主诉 + 现病史 →
体格检查 + 辅助检查 → 保存问诊 →
一键生成病历 → 必要时润色 →
AI 质控 → 修复问题 → 出具最终病历

12.2 提效技巧

- **复诊用语音续录**：在原录音基础上录一段"上次治疗后情况"，AI 会智能追加
- **批量处理影像**：影像科用 PACS 工作台 + 自动抽帧，避免一张张分析
- **善用追问建议**：右栏会实时提示鉴别诊断方向，可避免漏诊
- **一键补全**：质控有缺失时一键补，比手动写省时

12.3 避坑提示

- **现病史复诊**：必须写"上次治疗后变化"，否则质控不通过
- **辅助检查**：没有检查写"暂无"，**别留空**
- **签发前一定看一遍 AI 生成内容**：AI 偶尔会在没数据的字段写占位符或编造
- **录音环境**：在安静环境录，背景噪音会让识别质量下降
- **不要用 sing-box / V2Ray 等代理软件访问**：可能会让特定请求失败

12.4 数据安全

- 所有患者数据存储在上海节点，符合国内医疗数据合规要求
- HTTPS 加密传输；前端不缓存敏感数据
- 已签发病历不可篡改（审计合规）
- 影像 DICOM 文件存 Orthanc 服务，满足 PHI 隔离要求

十三、技术支持

生产地址：<https://mediscribe.cn>

异常反馈渠道：院内工作群或系统管理员

反馈时请提供： 1. 问题现象描述（什么操作 → 出现什么） 2. F12 控制台报错截图（如有） 3. 接诊号或患者标识（不含真实姓名） 4. 操作时间（精确到分钟）

文档版本：v2026.8.3 · 更新日期 2026-08-30 · 编写: 系统开发组

本指南**严格基于代码实现**编写，不涉及"理论上能做"但实际未实现的功能。如发现指南内容与系统实际不符，请优先以系统实际表现为准并反馈。